

Glomérulonéphrites:

- 1) Glomérulopathies 1°: GN à lésion minime, GN extramb, GN à dépôts IgA (maladie de Berger)
- 2) Glomérulopathies 2°: - non-immunologiques: diabète, amyloïdose
- immunologiques 2° à: infect°, lupus, vasculites, tumeurs, médicaments, Ig anti-MB...

Glomérulonéphrite à lésions minimes: enfants surtout

Lésion princ.: **podocyte**

Mécanisme: **act & infl. (T)**

perte structure "arabesque" MB

Facteurs étiologiques: **atopie, immunisat°, médicaments?**

Maladie extra-rénale assoc.: Maladie de Hodgkin, lymphomes

Présentat° clinique typique: **syndrome néphrotique**

Ttt immunologique: **stéroïdes + immunosuppr.**

GN extramembraneuse: → MB épaissie, dépôts → ↓ GFR

Lésion princ.: **podocyte et MB glom.**

Mécanisme: **auto-immun, complexes immuns in situ**

Fact. étiologiques: 1° ou 2°: assoc. au cancer

Maladie extra-rénale assoc.: Tumeur colon, prostate

Présentat° clinique typique: **syndrome néphrotique**

GN extramb 2°: **infect°** (hépatites, syphilis, malaria, ...) **maladie systémique** (LED, maladies auto-immunes), **néoplasies** (carcinomes, Hodgkin, autres lymphomes, leucémie myéloïde chronique), **médicaments** (sels d'
D-pénicillamine), **toxiques** (métaux lourds), causes **rares** (thyroïdite auto-immune, GVHD, ...)

Ttt: **non-immunologique** (ACE/ATI), **immunologique** (stéroïdes + immunosuppr.).

GN à dépôts mésangiaux d'IgA: maladie de Berger et purpura rhumatoïde.

Lésion princ.: **mésangium**

Mécanisme: glycosylat° IgA1 anormale? **IgA élevée**

Fact. étiol.: pas connus

Maladie extra-rénale assoc.: **purpura rhumatoïde**

Présentat° clinique typique: **hématurie**

Idiopathique ou isolé: **maladie de Berger**

Secondaire ou associée: purpura rhumatoïde (Henoch Schönlein), cirrhose éthylique.

Facteurs précipitant une hématurie: **infect° des VAS, gastro-entérite aiguë, hépatite A/B, infect°, vaccins**

Ttt: **non-immunologique** (ACE/ATI), **immunologique** (stéroïdes + immunosuppr. si atteinte sévère)

Facteurs de risque de mauvais pronostic: **hématurie importante, protéinurie > 1g/24h, HT imp., sévérité des lésions glom. et fibrose ils, > 40 ans, hommes, obésité.**

GN lupique: Lupus Erythémateux disséminé:

Lésion princ.: **ttes les & glom.**

Mécanisme: **immunologique** (dépôts complexes immuns in situ)

Fact. étiologiques: **inconnu**

Maladie extra-rénale assoc.: **LED**

Présentatⁿ clinique typique: **très variable** (IRA, syndr. néphritique, syndr. néphrotique, hématurie)

Manifestatⁿ **multiples**: peau et muq., rein, GI, arthrites, arthralgies, neurologiques, neuropsychiatriques, cardiovasculaires, pulmonaires, ophtalmiques, vasculaire, hématologique.

Classificatⁿ OMS des GN lupiques:

- Classe I: rein normal
- Classe II: GN mésangiale
- Classe III: GN proliférative **segmentaire et focale**
- Classe IV: GN proliférative diffuse
- Classe V: GN extramembraneuse
- Classe VI: GN sclérosante

Différentes classes peuvent coexister, classe IV a le + mauvais pronostic. Durant évolutⁿ maladie lupique, atteinte rénale peut **changer de classe**. Svt, nouvelle PBR → guider ttt.

GN rapidement progressives: vasculites ANCA+, GN pauci-immun, syndr. de Goodpasture, LED

ttt des LED, vasculites, GN anti-MB glom: **immunologique** (stéroïdes + immunosuppr. +/- plasmaphérèse)
non-immun (ACE/ATI).

→ gros/moyens/petits vx → inflam.
et destructⁿ glomérules.

Ig anti-MB ds poumons
et reins.

LED, vasculites et Ig anti-MB: différents points d'attaque, mais sans ttt le résultat final est identique: sclérose glom. et IR!

À retenir:

- diagnostic précis GN par PBR (Mo, IF, ME)
- ttt non-immunologique
- ttt immunologique
- histologie détermine ttt
- GN sont **étiologie imp. IR terminale.**